



REGULAMENTO FPC

REGULAMENTO MÉDICO

EQUIPAS CONTINENTAIS

(Monitorização da proteção da saúde dos Corredores)

Versão aprovada em reunião de Direção em 28.12.2022

Alterada em reunião de Direção em 23.02.2023

Alterada em reunião de Direção em 23.05.2025

Alterada em reunião de Direção em 04.09.2025

Índice

Preâmbulo – INTRODUÇÃO

Capítulo I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Capítulo II - CÓDIGO MÉDICO DO MOVIMENTO OLÍMPICO

Capítulo III – OS AGENTES MÉDICOS NO CICLISMO NACIONAL

- § 1 Comissão Médica UVP-FPC
- § 2 Médico UVP-FPC
- § 4 Médicos de equipa
- § 5 Agentes de saúde no Desporto

Capítulo IV – PROTEGER E PROMOVER A SAÚDE DOS CORREDORES

- § 1 Regras Gerais
- § 2 Acompanhamento médico das equipas Continentais UCI
- § 3 Interdição de injeções

Capítulo V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Preâmbulo – INTRODUÇÃO

Na prossecução de melhores práticas médico-desportivas, nomeadamente na defesa da integridade física dos corredores e na promoção de saúde na prática desportiva, a reorganização dos cuidados em saúde no ciclismo nacional tornou-se naturalmente uma exigência atual.

A UVP-FPC, tendo em vista criar condições e fomentar o exercício de uma medicina desportiva moderna, centrada na saúde dos corredores e na promoção do seu bem estar, entende ser adequada a criação e implementação de um regulamento médico UVP-FPC, aplicável às equipas continentais UCI portuguesas, que visa, fundamentalmente, garantir uma melhoria continuada da qualidade dos serviços médicos e cuidados de saúde prestados aos corredores das equipas continentais do pelotão nacional, a caminho da excelência, envolvendo todos os agentes desportivos do ciclismo português num compromisso de atualização permanente e de formação continuada, aumentando a segurança global da modalidade.

O indubitável compromisso de todos os agentes desportivos é fundamental para o cumprimento destes objetivos.

Capítulo I – DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.001** O presente Regulamento, denominado Regulamento Médico UVP-FPC, é aplicável a todas as equipas continentais UCI portuguesas e respetivos agentes desportivos que, a qualquer título ou por qualquer motivo, exerçam funções nessas equipas.
- 1.002** O presente Regulamento não se aplica às situações concretas em que, no âmbito de provas de ciclismo de estrada realizadas em Portugal e que façam parte do calendário internacional UCI, seja aplicável o Regulamento Médico da UCI.
- 1.003** Ocorrendo concurso de normas previstas neste Regulamento com normas legais ou do Regulamento Antidopagem da FPC, prevalecerão as constantes nestes últimos diplomas.

Capítulo II - CÓDIGO MÉDICO DO MOVIMENTO OLÍMPICO

- 2.001** Em 2009, O Comité Olímpico Internacional (COI) adotou o Código Médico do Movimento Olímpico abaixo reproduzido.
- O Código Médico do Movimento Olímpico não faz oficialmente parte do Regulamento do Ciclismo da UCI e da UVP-FPC. Não se trata de regras da UCI nem de obrigações formais. O referido Código expressa uma série de princípios, metas e objetivos destinados a guiar todos e todas que têm uma relação com a saúde e o cuidado dos corredores, e toda a atividade referida neste código, nomeadamente: os corredores, os seus médicos pessoais e os das equipas, as federações nacionais, os médicos das seleções nacionais, os assistentes paramédicos, os managers das equipas, os organizadores de provas de ciclismo e todo o pessoal médico que desempenhe um papel ou que esteja presente nas provas. É com este fim que o Código Médico do Movimento Olímpico é abaixo transcrito.
- 2.002** Fica estabelecido que, em caso de divergência com o Código Médico do Movimento Olímpico, prevalecerão as regras da UCI e da UVP-FPC.

Código Médico do Movimento Olímpico*

Em vigor a 31 março de 2016

Versão em INGLÊS: “Olympic Movement Medical Code”

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Medical-and-Scientific-Commission/Olympic-Movement-Medical-Code-31-03-2016.pdf#_ga=2.162685628.1265859574.1613582383-1982745790.1613582383

**NT: não existe a versão traduzida em Português.*

Capítulo III - OS AGENTES MÉDICOS NO CICLISMO NACIONAL

§ 1. Comissão Médica UVP-FPC

3.001 A Comissão Médica UVP-FPC (CM_UVP-FPC) é nomeada pela Direção da UVP-FPC, pelo período de um quadriénio, coincidente com o mandato de cada direção da UVP-FPC.

É constituída por um painel de três elementos médicos, sendo dois deles indicados pela direção da UVP-FPC e o terceiro pela UCI. Caso a UCI não faça uso da prerrogativa que lhe é conferida, então os três elementos serão indicados pela direção da UVP-FPC.

O objetivo primordial da CM_UVP-FPC é promover e monitorizar a saúde dos corredores das equipas continentais portuguesas, bem como o funcionamento médico-desportivo dessas equipas no seu contexto desportivo de competição e treino.

Os valores desta comissão passarão pela obediência aos códigos de conduta médico-desportiva determinados pelo COI, bem como obediência aos princípios de idoneidade, imparcialidade de decisões e respeito inequívoco da privacidade e proteção de dados individuais dos corredores.

A CM_UVP-FPC reunirá, presencialmente ou por meio de videoconferência, sempre que para o efeito seja convocada pelo Médico da UVP-FPC. A convocatória é feita através de correio eletrónico.

As reuniões da CM_UVP-FPC não são públicas.

Os membros da CM_UVP-FPC ficam sujeitos aos deveres de reserva e de confidencialidade sobre todas as matérias que sejam apreciadas e discutidas pela Comissão. Sem prejuízo de outras consequências, a violação de algum daqueles deveres implica a imediata perda do mandato.

São lavradas atas das reuniões, nas quais devem constar sumariamente descritas todas as questões apreciadas e as deliberações tomadas pela CM_UVP-FPC. As atas são assinadas por todos os membros da CM_UVP-FPC.

As deliberações da CM_UVP-FPC só são válidas quando na reunião estiverem presentes a maioria dos membros da Comissão e o assunto sujeito a votação obtiver o voto favorável da maioria dos presentes, podendo, porém, nos casos expressamente previstos neste Regulamento, exigir-se a unanimidade.

Os membros da CM_UVP-FPC são obrigados a comparecer às reuniões. A falta injustificada de um membro a duas reuniões seguidas, ou a quatro interpoladas, determina a perda do mandato.

§ 2. Médico da UVP-FPC

3.002 O Médico da UVP-FPC é obrigatoriamente um dos elementos nomeados pela Direção da UVP-FPC para a comissão médica UVP-FPC. O médico UVP-FPC deverá possuir competências teórico-práticas demonstradas na área da Medicina-desportiva (especialidade ou pós-graduação reconhecidas pelo Colégio de Especialidade de Medicina Desportiva da Ordem dos Médicos e/ou pela Sociedade Portuguesa de Medicina-Desportiva e/ou pelo COI).

3.003 Os valores do cargo passarão por obediência aos códigos de conduta médico-desportiva determinados pelo COI, e respeito inequívoco da privacidade e proteção de dados individuais

dos corredores, sem prejuízo dos pressupostos determinados pelo código deontológico da profissão.

- 3.004** Os principais objetivos do cargo deverão basear-se em instituir e preservar as melhores práticas médico-desportivas nas equipas continentais portuguesas, coordenar o trabalho da CM_UVP-FPC e ser o porta-voz da UVP-FPC na CM_UVP-FPC para as questões médicas sempre que necessário.

§ 3. Médico de Equipa

- 3.005** Cada equipa Continental UCI tem o dever de nomear um médico para a função de Médico de Equipa. Dentro do possível, a equipa deverá nomear um médico com experiência em medicina desportiva.
- 3.006** Definem-se os critérios basilares para médicos titulares de uma licença de médico de equipa emitida pela UVP-FPC:
1. Detentor de um diploma médico reconhecido pela Ordem dos Médicos Portugueses, ser autorizado a exercer medicina sem qualquer restrição, e, de preferência, ter conhecimentos no domínio da medicina desportiva; e,
 2. Diploma de realização da Formação da “WADA e-Learning for medical professionals” - <https://adel.wada-ama.org>.
- 3.007** O Médico de Equipa deverá obter uma licença da UCI junto da UVP-FPC. No caso de não residentes em Portugal, a credencial emitida pela UVP-FPC certificará que todas as condições previstas no presente regulamento para licenciados como “Médico da Equipa” foram respeitadas.
- A licença do Médico da Equipa deverá ser apresentada no momento da confirmação das licenças em todas as provas em que este esteja presente.
- 3.008** O Médico de Equipa tem o dever de estabelecer contacto permanente e cooperação com a CM_UVP-FPC, devendo estar na plena capacidade de atualização constante sobre o estado clínico dos corredores, bem como assegurar a coordenação de todas as ações da equipa no domínio da saúde e da medicina. Além disso, deverá prover os cuidados médicos aos respetivos corredores segundo o atual estado da arte, obedecendo ao código médico do movimento olímpico e código mundial antidopagem.
- 3.009** Neste contexto, “cuidados médicos” significa cuidados médicos amplos, nomeadamente nos seguintes domínios: avaliação médica dos corredores, verificação de aptidão para participar na competição, tratamento de lesões e doenças derivadas do desporto, prescrição de medicamentos a tomar durante uma atividade desportiva e conselhos sobre nutrição e treino.
- 3.010** Qualquer acordo ou prática que ligue a remuneração de um médico de equipa aos resultados, performance ou rendimento desportivo de um ou mais corredor(es), ou da equipa, são interditas.
- 3.011** Além das obrigações contratuais com a equipa, o papel e as responsabilidades de um médico de equipa incluem:

1. Ter como preocupação principal prestar os melhores cuidados médicos possíveis aos corredores da equipa, quaisquer que sejam o seu nível e circunstâncias, e prever o tempo e o trabalho necessários para este fim;
2. Continuar a aperfeiçoar-se no domínio da medicina desportiva;
3. Adquirir e manter conhecimentos básicos no domínio médico-legal, da definição de incapacidade e da interação com seguros desportivos;
4. Adquirir e manter um conhecimento profundo das especificidades desportivas ligadas às disciplinas do ciclismo dos corredores da equipa;
5. Coordenar as avaliações médicas e as verificações de aptidão desportiva antes da participação numa prova;
6. Prevenir e gerir as lesões e doenças;
7. Coordenar a reabilitação e o retorno à competição;
8. Prever um condicionamento adequado para assegurar um regresso à competição com o menor risco possível após uma doença ou lesão;
9. Integrar a sua experiência médica com a de outros interveniente em saúde;
10. Fornecer documentação e gestão dos dossiers médicos de forma adequada;
11. Participar em sondagens, estudos científicos, e outras iniciativas no domínio da saúde, destinadas a melhorar os cuidados médicos no ciclismo;
12. Estabelecer e definir o papel de todas as partes no âmbito da equipa e as ligações entre elas relativamente à proteção da saúde;
13. O Médico de Equipa terá o dever de estabelecer contacto permanente e cooperação com a CM_UVP-FPC e colocar em prática uma cadeia hierárquica no seio da equipa para todas as questões relacionadas com a saúde;
14. Informar o corredor, o manager da equipa, diretor desportivo (adiante DD) e/ou treinador e as outras partes envolvidas em caso de suscetibilidade/risco relativamente à saúde de um corredor;
15. Preparar um plano de ação e de o treinar na sua aplicação em caso de urgência/emergência durante uma competição ou um treino;
16. Tratar das questões relacionadas com os suprimentos e o material médico;
17. Prestar a assistência médica necessária em caso de uma ocorrência;
18. Avaliar os fatores ambientais, bem como as condições mais favoráveis para o bem-estar dos corredores.
19. Avaliar os riscos da ingestão de substâncias nutricionais.

Nota: As responsabilidades do médico de equipa não anulam e não afetam as responsabilidades que outras pessoas têm ao abrigo dos Regulamentos da UVP-FPC.

3.012 O Médico de Equipa deverá abster-se de participar em atos e na utilização de métodos interditos pelo regulamento antidopagem da UCI e da UVP-FPC.

§ 4. Médico da Prova

- 3.013** O Médico da Prova terá de ser titular de licença, dispor de experiência e conhecimentos na área da medicina desportiva e terá o dever de estabelecer contacto e colaboração com a Comissão Médica. Para além disso, compete-lhe ainda prestar cuidados médicos aos corredores, durante as provas, respeitando os objetivos que o presente Regulamento tem em vista, observando e fazendo observar, em tudo o que dependa da sua atividade, o que se prescreve no mesmo.
- 3.014** São aplicáveis ao Médico da Prova, com as necessárias adaptações, os mesmos deveres, obrigações e responsabilidades previstas na secção precedente deste Regulamento, para o Médico de Equipa, bem como as sanções a que aludem os parágrafos seguintes.

Sanções

- 3.015** A violação do disposto no Artigo 3.010 consubstancia a prática de ilícito disciplinar muito grave, sendo a conduta do médico de equipa infrator sancionada com suspensão da atividade pelo período de 1 (um) mês a 1 (um) ano e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €1.000,00 (mil euros) e os €10.000,00 (dez mil euros).
- 3.016** Qualquer violação do disposto nos pontos 13 ou 14 do Artigo 3.011 ou no Artigo 3.012, consubstancia a prática de ilícito disciplinar grave, sendo a conduta do médico de equipa infrator sancionada com suspensão de atividade pelo período de 8 (oito) dias a 1 (um) mês e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €500,00 (quinhentos euros) e os €1.000,00 (mil euros).

§ 4. Agentes de Saúde no Desporto*

Definição

- 3.017** Integram a qualidade de “agentes de saúde no desporto (ASD)” todos os agentes que, nas equipas continentais, de forma regular, a pedido ou por iniciativa direta ou indireta de uma federação nacional, de uma equipa, de um sponsor, de um clube ou de qualquer outra entidade de ciclismo, prestem a um corredor qualquer tipo de cuidados de saúde ligados à preparação, recuperação ou à participação em provas de ciclismo, nomeadamente administrando-lhe – sob a supervisão de um médico de equipa – medicamentos ou um qualquer tratamento em caso de lesão, ou no decorrer da recuperação desportiva.

Nota: a denominação UCI da figura “paramédicos” não existe em Portugal. Deverá ser feita a correspondência para “agentes de saúde no desporto”, a nível de competências, às funções definidas pela legislação nacional como sendo profissional de saúde, estando sujeito a termos éticos e deontológicos. De forma operacional, define-se ASD a todo e qualquer elemento pertencente a uma equipa com formação e certificação na área da saúde, na qual o médico responsável da mesma delegue funções de supervisão e cuidados de saúde ligados a preparação, recuperação ou à participação em provas de ciclismo sob sua supervisão e conhecimento. Nenhuma função do ASD deverá colidir com as funções ou desígnios do médico responsável, de forma a garantir a existência do cumprimento ético e deontológico inerente.

Licença

- 3.018** Com exceção dos médicos titulares de uma licença UCI de médico de equipa, ninguém poderá atuar enquanto ASD sem ser titular de uma licença desportiva com a denominação ASD (agente de saúde no desporto) conjugada com a competência profissional apresentada, Ex: ASD- Massagista, ASD- Fisioterapeuta, ASD- Enfermeiro(a), ASD- Nutricionista, etc.
- 3.019** A licença de ASD é emitida pela UVP-FPC. No caso de não residentes em Portugal, a credencial emitida pela UVP-FPC certificará que todas as condições previstas no presente regulamento para licenciados como “ADS” foram respeitadas.
- As licenças de todos os ASD presentes na prova deverão ser apresentadas no momento da confirmação das licenças.
- 3.020** Os requisitos mínimos cumulativos para a obtenção de uma licença de Agente de Saúde no Desporto são:
1. Apresentação prévia de pedido de filiação na UVP-FPC, devidamente preenchido e assinado, no modelo oficial a estabelecer pela UVP-FPC, no qual o signatário requerente se obriga a respeitar escrupulosamente o presente Regulamento Médico;
 2. Dentro da equipa, deverá ser dada prioridade de licenciamento para estas funções a pessoas titulares de um diploma profissional na área da saúde ou experiência profissional nesta área e que tenham continuado a aperfeiçoar-se no domínio dos serviços que deverão prestar aos corredores, que tenham experiência e conhecimento prático dos problemas de saúde que afetam os corredores e conhecimentos de primeiros socorros básicos para um evento desportivo;
 3. Seja titular de Diploma de realização da Formação da “WADA e-Learning for medical professionals” - <https://adel.wada-ama.org>.
- 3.021** Está vedado a qualquer equipa de ciclismo contratar pessoa para o desempenho das funções de ASD que não se encontre devidamente licenciado para o efeito, nos termos estabelecidos na presente secção.
- 3.022** Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete ainda à equipa de ciclismo, e em especial ao representante da equipa na UVP-FPC e na UCI, garantir que, em competição e/ou estágio da equipa, não é permitida a presença junto da equipa, ou de qualquer corredor, de pessoa que desempenhe as funções de ASD sem se encontrar, para o efeito, devidamente licenciado.

Regras de Conduta

- 3.023** O ASD estará sempre sobre a jurisdição do médico de equipa, reportando qualquer circunstância clínica em curso, não tendo autonomia para tomadas de decisão terapêutica ou de indução de fármacos sem prévia consulta e supervisão médica. Só poderá aplicar fármacos a corredores com autorização do médico com informação enviada por escrito.
- 3.024** O ASD compromete-se a prestar os melhores cuidados de saúde possíveis aos corredores, quaisquer que sejam o seu nível e circunstâncias, e a prever o tempo e o trabalho necessários para este fim.

- 3.025** O ASD deverá adquirir e manter um conhecimento profundo das especificidades desportivas ligadas às disciplinas do ciclismo dos corredores da equipa e continuará a aperfeiçoar-se nestes domínios de atividade.
- 3.026** O ASD respeitará e garantirá o respeito dos imperativos de saúde dos corredores, da deontologia desportiva e dos regulamentos da UCI e da UVP-FPC. Está sujeito ao sigilo profissional.
- 3.027** O ASD colocará a saúde do corredor acima dos interesses eventuais da sua equipa, clube, sponsor ou seleção nacional que o poderiam prejudicar. Deverá opor-se à participação de um corredor em sessões de treino ou em provas, caso a proteção da saúde e da segurança deste não possam ser garantidas. Terá um papel ativo na prevenção de lesões e na informação aos corredores.
- 3.028** O ASD evitará e lutará contra todas as situações e circunstâncias que tenham como risco um efeito nefasto para a integridade física ou o bem-estar físico do corredor.
- 3.029** O ASD limitará as suas atividades aos atos que a sua formação e experiência lhe permitem executar garantindo a sua qualidade e segurança.
- 3.030** Os cuidados prestados deverão corresponder às necessidades reais do corredor e às melhores práticas em saúde. O ASD deverá abster-se de proceder a qualquer tratamento experimental.
- 3.031** O ASD deverá abster-se de executar qualquer ato que possa ser interdito pelas leis nacionais ou do país onde exerce a sua profissão.
- 3.032** O ASD terá de seguir as instruções do médico no tratamento de um corredor doente ou lesionado. Em nenhuma circunstância deverá autonomizar-se nesta tarefa, ou ignorar os determinismos clínicos efetuados pelo médico da equipa.
- 3.033** Em especial, o ASD deverá abster-se de participar em atos e na utilização de métodos interditos pelo regulamento antidopagem da UCI e da UVP-FPC.

Direitos Fundamentais do Corredor

- 3.034** O ASD não poderá executar nenhum ato de saúde a um corredor sem o consentimento deste, nem a seu pedido, contra os regulamentos antidopagem.
- 3.035** O ASD informará o corredor da natureza e do objetivo de qualquer tratamento administrado, e das suas consequências.
- 3.036** O corredor tem o direito de ser informado de qualquer aspeto relativo à sua saúde ou ao seu estado psíquico ou físico que o ASD tenha constatado.
- 3.037** O ASD respeitará a vida privada do corredor e, desta forma, será discreto quanto aos cuidados administrados, com exceção da sua obrigação de divulgar as informações exigidas pelos ou em virtude dos regulamentos da UCI e da UVP-FPC, ou uma disposição legal.

Sanções

- 3.038** Qualquer violação do disposto no Artigo 3.018 consubstancia a prática de ilícito disciplinar muito grave, sendo a conduta do agente desportivo (atuante como ASD) infrator sancionada com sanção de impossibilidade de inscrição na FPC pelo período de 1 (uma) a 3 (três) épocas desportivas e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €500,00 (quinhentos euros) e os €5.000,00 (cinco mil euros).
- 3.039** Qualquer violação do disposto nos Artigos 3.021 e 3.022 consubstancia a prática de ilícito disciplinar muito grave, sendo a conduta do representante da equipa na UVP-FPC e na UCI infrator sancionada com suspensão de atividade de 1 (um) mês a 6 (seis) meses e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €500,00 (quinhentos euros) e os €5.000,00 (cinco mil euros).
- 3.040** Qualquer violação do disposto nos Artigos 3.023, 3.026, 3.027, 3.028 e 3.030, 3.031, 3.032, 3.033 ou 3.034 consubstancia a prática de ilícito disciplinar grave, sendo a conduta do ASD infrator sancionada com suspensão de atividade pelo período de 8 (oito) dias a 6 (seis) meses e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €500,00 (quinhentos euros) e os €5.000,00 (cinco mil euros).

Capítulo IV – PROTEGER E PROMOVER A SAÚDE DOS CORREDORES

§ 1. Regras Gerais

- 4.001** Cada corredor cuidará da sua própria forma física e prestará atenção aos riscos que podem ameaçar a sua saúde e segurança.
- 4.002** Cada equipa abrangida pelo presente Regulamento, deverá assegurar constantemente e sistematicamente que os seus membros estão em boa forma para praticar o ciclismo.

A equipa deverá assegurar igualmente que os seus corredores praticam a modalidade em boas condições de segurança. Esta deverá garantir, em particular, que um corredor esteja em boas condições de saúde física e psicológica no retorno à competição após paragem da sua atividade desportiva.

- 4.003** No decorrer de uma prova de ciclismo, é responsabilidade do médico da equipa ou do médico de prova, determinar se um corredor vítima de doença ou trauma pode retomar a sua atividade competitiva na corrida. Esta decisão não pode ser delegada noutro profissional ou membro do staff. A prioridade deverá ser sempre dada à proteção da saúde e da segurança do corredor e do pelotão. O potencial resultado da competição não poderá nunca influenciar qualquer decisão.

Se a opinião do médico da equipa diferir da do médico da prova quando se trata de decidir se um corredor pode continuar ou retomar a prova, o corredor não poderá continuar em prova.

- 4.004** Além do acompanhamento médico previsto pelo presente regulamento, as equipas têm toda a liberdade de ação relativamente à proteção da saúde e ao acompanhamento médico dos seus corredores.

É recomendada uma avaliação médica para determinação de aptidão antes de participar numa competição após um período de paragem por lesão ou doença.

§ 2. Acompanhamento médico das Equipas Continentais UCI

Generalidades

- 4.005** Com os pressupostos definidos no Artigo 4.002, a equipa configurará, organizará e implementará um programa de prevenção e de segurança - “Programa de monitorização clínica” que deverá incluir no mínimo, a lista dos exames exigidos e as medidas de prevenção dos riscos descritos no ponto 4.015 e, bem assim, cumprir os requisitos definidos pela CM_UVP, nos termos do Artigo 4.012. Sem prejuízo do que antecede, o Médico da Equipa pode alargar o âmbito do “Programa de Monitorização Clínica”, abrangendo, no mesmo, outros parâmetros, para além dos mínimos definidos neste Regulamento.
- 4.006** O Representante da Equipa na UCI e na UVP-FPC será responsável por organizar e implementar este programa e, em geral, por garantir o cumprimento de todas as obrigações que, no presente Regulamento, se impõem à equipa. O médico da equipa será responsável pelos aspetos médicos.
- 4.007** A equipa não poderá obrigar nem permitir que um corredor participe em provas caso o médico da equipa não o considere apto para o fazer.
- 4.008** Caso o médico da equipa descubra um qualquer facto que, na sua melhor opinião clínica, signifique que o corredor não está apto (mesmo que temporariamente) para participar em provas, o corredor deverá ser declarado inapto, sendo dada a informação ao Representante da Equipa na UCI e na UVP-FPC. O período durante o qual o corredor será considerado inapto será determinado pelo médico da equipa. Esta decisão assim como a declaração de inaptidão serão consignadas por escrito e anexas ao dossier médico do corredor.
- 4.009** O Representante da Equipa na UCI e na UVP-FPC, bem como o DD (caso não o seja) têm a obrigação de apoiar o médico da equipa no tratamento instituído ao corredor, nunca sendo um elemento obstaculizante ao processo.
- 4.010** O Médico da Equipa deve acompanhar todas as provas por etapas com mais de 7 dias de duração, cabendo-lhe de definir a forma de acompanhamento. O Médico da Equipa, através de justificação válida aceite pela UVP-FPC, poderá ser substituído por outro médico que deverá estar filiado na UVP-FPC na função de médico adjunto da equipa.
- 4.011** Os médicos das equipas darão conhecimento à CM_UVP-FPC dos riscos observados bem como de toda e qualquer informação ou sugestão que possam ser úteis ao ciclismo em matéria de proteção da saúde, de medicina e de prevenção.

Programa de monitorização clínica

4.012 O “Programa de monitorização clínica” é de carácter obrigatório e tem como finalidade capacitar os médicos das equipas para uma maior efetividade na vigilância do estado de saúde dos corredores que estão sob a sua responsabilidade clínica.

Os requisitos mínimos deste programa serão definidos pela CM_UVP-FPC, cabendo às equipas implementá-lo e aplicá-lo no estrito cumprimento daqueles requisitos, cujos intervalos temporais para a aplicação das avaliações médico-desportivas adiante elencadas em 4.015 serão definidos anualmente pela mesma.

Nota: Não cabe à CM_UVP-FPC monitorizar o estado de saúde ou quaisquer parâmetros analíticos dos corredores das equipas, esta função será feita exclusivamente pelo médico da equipa. No entanto, a CM_UVP-FPC poderá prover suporte e orientação caso esta seja solicitada pelo médico responsável.

4.013 A implementação do “Programa de monitorização clínica” deverá ser aplicada a todos os corredores das equipas Continentais UCI portuguesas sem exceção.

4.014 Quando um corredor é contratado por uma equipa Continental UCI portuguesa, o programa de exames obrigatórios deverá integrar, para além do mais, um check-up médico, a realizar obrigatoriamente ao corredor antes deste iniciar qualquer atividade desportiva, competitiva ou não.

4.015 Os exames e meios complementares de diagnóstico infra descritos integram o programa mínimo de monitorização clínica e devem obrigatoriamente ser aplicadas pelos Médicos das Equipas:

Programa de Avaliação de Saúde UVP-FPC – Equipas Continentais UCI				
Exames	A cada 2 anos	A cada ano	Dois períodos intercalares anuais***	Opcional
Exame Médico-Desportivo (EMD)			*	
Questionário cardíaco		*		
ECG de 12 derivações		*		
Prova de Função Respiratória (PFR)		*		
Eco Doppler cardíaco	*			
Prova de esforço cardiopulmonar (CPET)	*			
Ureia e Creatinina		*		
Hemograma completo			*	
Contagem de reticulócitos			*	
Ferritina			*	
Proteína C Reativa			*	
Glucose		*		
TSH		*	*	
T4 livre		*		
Testosterona Total			*	
Cortisol			*	
Exame sumário de urina	*			
Serologias para HCV/HIV/HBV				*
Vacinação tétano				*
Vacinação completa com reforço - COVID-19				*

TGO+ TGP				*
Colesterol				*
HDL				*
LDL				*

*** Períodos de avaliação analítica a definir anualmente pela comissão médica, mediante ajustamento ao calendário de competições.

- 4.016** Os exames deverão ser realizados de forma que os resultados possam ser parte integrante da avaliação de aptidão do corredor para treinar ou participar em competições.
- 4.017** Os custos dos exames obrigatórios constantes no programa de vigilância de saúde serão da responsabilidade das respetivas equipas.
- 4.018** O médico de uma equipa continental UCI, organizará e manterá um dossier médico individual para cada um dos corredores da equipa.
- 4.019** Este dossier médico deverá conter todos os resultados dos exames que têm de ser realizados pelo corredor em questão em virtude das disposições do presente regulamento, bem como toda outra informação útil relativa à saúde e aptidão do corredor, a qual será incluída com o seu consentimento.
- 4.020** O dossier médico pertence ao corredor, mas deve ser mantido pelo seu médico de equipa. Mediante solicitação prévia, o corredor tem direito a, a todo o tempo e num prazo razoável, aceder ao seu processo clínico para consulta, ou a que lhe seja fornecida cópia ou uma segunda via do dito processo, com todos os exames e meios complementares de diagnóstico dele constantes.
- 4.021** O médico da equipa, e se necessário for, a CM_UVP-FPC tratarão os resultados dos exames como informações confidenciais, não obstante a obrigação que compete ao médico da equipa de declarar, se for o caso, que um corredor está inapto para treinar ou para participar numa competição.
- 4.022** O dossier médico será entregue ao corredor quando este cessar a sua ligação à equipa. O corredor transmite-o ao médico da sua nova equipa.
- 4.023** Todos os documentos datados de há 10 anos ou mais serão eliminados do dossier médico.

Vigilância do processo de monitorização de saúde das equipas

- 4.024** A pedido da CM_UVP-FPC, nos prazos e segundo os procedimentos que esta fixe, o médico da equipa fornecerá a prova de que os exames obrigatórios previstos pelo presente regulamento foram realizados, bem como as explicações e informações que sejam solicitadas.
- 4.025** Não obstante apenas o corredor e o respetivo médico da sua equipa terem acesso ao dossier médico, a CM_UVP-FPC tem direito à sua consulta, salvaguardando o disposto no Artigo 4.026, sempre que necessário e assim for determinado por esta comissão.

A consulta do dossier clínico de um corredor por parte da CM_UVP-FPC deverá ocorrer sempre com o conhecimento do corredor em causa e do respetivo médico de equipa.

A CM_UVP-FPC, após a consulta do dossier clínico, poderá solicitar a repetição de algumas análises previstas no Artigo 4.015. Os exames deverão ser reavaliados pela comissão e pelo médico da equipa.

A decisão de aptidão médica do ciclista para competir deverá ser acordada entre a CM_UVP-FPC e o médico da equipa;

O custo com os exames analíticos obrigatórios será suportado pela UVP-FPC, sempre que os mesmos sejam efetuados num dos seus laboratórios parceiros. Caso contrário, os atletas/equipas deverão proceder a avaliação às suas expensas próprias.

- 4.026** A CM_UVP-FPC assegurará que nenhuma outra pessoa tem acesso às informações médicas dos corredores, com exceção dos seus médicos de equipa.

Sanções

- 4.027** Qualquer violação do disposto no Artigo 4.009 consubstancia a prática de ilícito disciplinar muito grave, sendo a conduta do representante da equipa na UVP-FPC e na UCI ou do DD infrator sancionada com suspensão de atividade de 1 (um) mês a 1 (um) ano e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €1.000,00 (mil euros) e os €10.000,00 (dez mil euros).
- 4.028** Qualquer violação do disposto nos Artigos 4.005, 4.007, 4.008, 4.010, 4.012 e 4.013 consubstanciam a prática de ilícito disciplinar grave, sendo a conduta do representante da equipa na UVP-FPC e na UCI infrator sancionada com suspensão de atividade de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €500,00 (quinhentos euros) e os €5.000,00 (cinco mil euros).
- 4.029** Qualquer violação do disposto nos Artigos 4.015, 4.016, 4.018 e 4.019, 4.020, 4.021, 4.024, 4.025 e 4.026 consubstanciam a prática de ilícito disciplinar grave, sendo a conduta do médico da equipa infrator sancionada com sanção de suspensão de atividade de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês e, acessoriamente, com multa a fixar entre os €500,00 (quinhentos euros) e os €5.000,00 (cinco mil euros).
- 4.030** Qualquer violação do disposto no Artigo 4.014 consubstancia a prática de ilícito disciplinar leve, sendo a conduta do médico da equipa infrator sancionada com sanção de multa a fixar entre os €100,00 (cem euros) e os €1.000,00 (mil euros).

§ 3. Interdição de Injeções

Nota: este tópico tem por objetivo a interdição de injeção de medicamentos ou substâncias que não tenham uma indicação médica precisa (ou seja, vitaminas, enzimas, cofatores, açúcares, aminoácidos, proteínas, antioxidantes, etc.). Trata-se em particular das injeções destinadas a melhorar ou acelerar a recuperação ou o combate à fadiga.

- 4.031** A UVP-FPC é solidária e adotará a mesma política “no needle’s” implementada pela UCI e pela IOC. Esta política tende a clarificar os critérios de uso e posse de métodos/substâncias

que potencialmente possam ser utilizadas de forma abusiva, tal como os glucocorticoides. A principal finalidade é evitar práticas médicas aberrantes, ou inibir procedimentos injetáveis por parte de pessoas não médicas sem qualquer justificação clínica, tais como corredores e staff de equipas.

A política “no needle’s” foi implementada por várias federações desportivas internacionais obtendo ganhos objetivos em saúde dos seus corredores e tornando mais transparente todo o processo associado ao uso deste recurso terapêutico.

Esta política tende a ser uma abordagem construtiva de forma a coibir o abuso de práticas de injeção de glucocorticoides potencialmente perigosas ou desnecessárias, e não a estigmatizar ou penalizar corredores ou médicos.

4.032 O uso e a posse de substâncias ou métodos injetáveis, tais como seringas, agulhas, fármacos na sua formulação injetável, etc., apenas serão permitidas estar na posse e responsabilidade do médico da equipa. Este último será responsável pela validade, integridade e correto acondicionamento dos mesmos.

4.033 A injeção de qualquer substância em qualquer parte do corpo de um corredor é interdita, exceto se todas as condições a seguir indicadas estejam reunidas:

1. A injeção deverá ser justificada de acordo com as melhores práticas clínicas segundo o estado da arte atual. Este processo de justificação na forma de um relatório pressupõe um exame clínico efetuado por um médico registado na ordem profissional e com idoneidade para a profissão, a existência de um diagnóstico, a descrição dos medicamentos prescritos e a correta discriminação da via de administração;

2. Não existe nenhum outro tratamento possível sem injeção;

3. A razão da injeção deve corresponder às indicações terapêuticas aprovadas pelo fabricante para o medicamento em questão;

4. A injeção deverá ser administrada por um médico registado, exceto se o corredor padecer de uma doença que necessita de auto injeções (como por exemplo no caso da Diabetes Melitos);

5. O médico da equipa, deverá reportar imediatamente, e por escrito até um período não superior a 24h à administração, enviando um relatório clínico a justificar devidamente o procedimento segundo os pressupostos do ponto 4.031 à CM_UVP-FPC. Este processo deverá estar sob a responsabilidade do próprio Corredor, (por email: comissaomedica@fpciclismo.pt), com exceção:

a. para os corredores com uma AUT válida;

b. para vacinação;

c. se a injeção é administrada no âmbito de um tratamento hospitalar ou de um meio complementar de diagnóstico;

d. se enquadre na prática de gestão de uma doença que necessita de injeções e se injete ele próprio.

Nota ao ponto 5: Caso o Corredor tenha sido intervencionado por um procedimento injetável, em competição ou fora de competição, por outro médico que não o médico da equipa, o corredor será responsável pelo envio do relatório ao médico da equipa e à CM_UVP-FPC.

- 4.034** A interdição prevista no artigo 4.033 inclui todas as substâncias injetáveis, quer seja endógena ou exógena, e quer seja interdita em virtude do regulamento antidopagem da UCI ou não.
- 4.035** A interdição prevista no artigo 4.033 inclui todo o tipo de injeções: intravenosa, intramuscular, intra-articular, periarticular, peritendinosa, epidural, intradérmica, subcutânea, etc.
- 4.036** No caso dos procedimentos injetáveis com recurso aos glucocorticoides, que são igualmente sujeitos ao regulamento antidopagem da UCI e UVP-FPC, e que fazem parte das listas das substâncias proibidas em competição, o corredor tem o dever de efetuar paragem desportiva e ser excluído, por questões de saúde, de competir durante ~~este~~ **trinta dias**. **Este período de paragem desportiva pode ser reduzido, até um mínimo de oito dias, a solicitação do corredor e/ou do médico que prescreveu o tratamento e/ou do médico da equipa, por decisão da CM_UVP-FPC, em face de documentação clínica sobre o motivo e as circunstâncias do tratamento que lhe sejam apresentadas. (Alterado em 04.09.2025)**

A administração injetável de glucocorticoides fora de competição, mesmo sob autorização de utilização terapêutica válida determinada pela ADOP, deverá ser declarada pelo corredor à CM_UVP-FPC num período não superior a 24 horas após a administração e nunca após as 24h prévias à participação do corredor em competição, tudo sem prejuízo do cumprimento previsto na legislação dopagem, sempre e na medida em que esta seja igualmente aplicável.

Sem prejuízo do que antecede, o médico da equipa pode, em nome do Corredor, apresentar a referida declaração.

O médico que prescreveu e/ou procedeu o tratamento injetável com glucocorticoides tem o dever de instituir abstinência competitiva por escrito ao corredor e anexará uma cópia desta certificação assinada por si e pelo corredor à documentação mencionada 4.033-1.

O médico que prescreveu o tratamento, ou em sua substituição o médico da equipa, **tem o dever de proceder a um controlo do cortisol sanguíneo às 8h00 da manhã, de cinco em cinco dias, durante o período de paragem desportiva**, e de proceder a um controlo do cortisol sanguíneo às 8h00 da manhã, das 24h que precedem o momento da eventual retoma à competição do corredor. A dosagem do cortisol deverá ser efectuada preferencialmente por um método de espectrometria de massa. **(Alterado em 04.09.2025)**

Os resultados ~~desta dosagem~~ **destas dosagens** e a decisão de aptidão médica para o regresso à competição serão enviadas pelo médico da equipa à CM_UVP-FPC de acordo com as mesmas modalidades previstas no artigo 4.033-5. **(Alterado em 04.09.2025)**

Os valores de referência para definição de normalidade analítica utilizados pela CM_UVP-FPC serão os mesmos determinados pela Comissão Médica UCI, publicados <https://assets.ctfassets.net/76117gh5x5an/6hRvcnnK1ygvk2ZveWb4n5/5b56b27eec9a626831f5e6cd96ccf6db/procedure-pathological-result-road.pdf>

No caso de os valores analíticos referentes ao cortisol não estarem em conformidade, o corredor tem o dever de repetir novamente o controlo analítico ao cortisol, sanguíneo às 8h da manhã, 72 horas após a primeira colheita, mantendo-se em abstinência competitiva até nova definição de aptidão.

Caso o corredor se mantenha com resultado analítico ao cortisol irregular após a segunda amostragem, caberá à CM_UVP-FPC em conjunto com o médico da equipa determinar as condições para aptidão.

Os corredores ficam obrigados, nos casos de controlos analíticos ao cortisol, a solicitar ao laboratório o envio direto dos resultados à Comissão Médica da UVP-FPC, por meio de correio eletrónico, para o endereço comissaomedica@fpciclismo.pt. Para tal efeito, os corredores deverão subscrever uma declaração, nos seguintes termos: "DECLARAÇÃO, F....., corredor filiado na União Velocipédica Portuguesa-Federação Portuguesa de Ciclismo, titular da licença com o nº, para a época desportiva de, declara, para os devidos efeitos que, nos termos do disposto no ponto 4.036 do Regulamento Médico das Equipas Continentais (Monitorização da Proteção da Saúde dos Corredores), os resultados dos controlos analíticos ao cortisol a que o declarante se submeteu devem ser remetidos diretamente à Comissão Médica da UVP-FPC por correio eletrónico, para o endereço comissaomedica@fpciclismo.pt, o que expressamente solicita., ... de de, O Declarante".

Vigilância e monitorização da política “no needle’s” e de procedimentos injetáveis com recurso a corticosteroides

- 4.037** O uso indevido e não justificado de substância injetáveis como os glucocorticoides podem levar a dano ou a maior suscetibilidade de doença. Eventos adversos com associações causais bem estabelecidas atingem virtualmente todos os sistemas orgânicos e funcionais do corpo humano, variam de consequências negativas de um espectro agudo ou crónico, de maior ou menor intensidade, destas incluem-se: insuficiência adrenal, imunodeficiência, osteoporose, perda de massa muscular, fragilidade estrutural de tendão/fáscia, necrose avascular da cabeça do fémur, desequilíbrio hidroeletrólítico, desregulação de absorção de nutrientes essenciais entre outros desequilíbrios metabólicos, glaucoma e cataratas.

Apenas uma única injeção intra-articular pode resultar em insuficiência adrenal clinicamente significativa que pode levar a disfunção multissistémica e imunossupressão por várias semanas.

Além dos factos já mencionados, um corredor que sofre uma lesão por trauma grave pode ter um risco aumentado de crise adrenal devido à supressão hipotálamo-hipofisária-adrenal resultante do uso prévio de glucocorticoides. Isso pode ser particularmente problemático se o corredor não divulgar previamente o seu uso ou associar outros fármacos concomitantemente (nomeadamente os anti-inflamatórios não esteroides). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6923944/pdf/bjsports-2018-100196.pdf>.

Tendo em conta este facto e especificamente para estas substâncias a CM_UVP-FPC terá especial atenção criando regras de monitorização dos procedimentos injetáveis.

- 4.038** Pelo carácter de preocupação sobre a preservação e integridade dos corredores envolvidos nas competições de ciclismo em Portugal, a CM_UVP-FPC tem o direito de requerer avaliação analítica constada na tabela do ponto 4.015, especialmente ao cortisol, devendo ser fixado ao corredor um prazo de 72 horas, a contar da notificação, para realizar o controlo analítico ao cortisol e apresentar o respetivo resultado. Este controlo poderá ser aplicado a corredor(es) ou equipa(s) caso assim a comissão o determine ser pertinente. A CM_UVP-FPC poderá igualmente e de acordo com os procedimentos previstos neste regulamento, solicitar aos ciclistas pertencentes às equipas de clube, que participem nas provas em conjunto com as equipas continentais, os exames previstos no ponto 4.015. Para o pagamento das mesmas aplica-se o mesmo pressuposto descrito no artigo 4.025.

No caso de os valores analíticos referentes ao cortisol serem considerados desconformes pela CM_UVP-FPC, por deliberação tomada por unanimidade dos três membros da Comissão, o corredor é notificado dessa desconformidade e fica automaticamente impedido de competir, devendo repetir novamente o controlo analítico ao cortisol nas 72 horas após a primeira recolha.

Caso o resultado analítico do controlo realizado nas 72 horas seguintes revele um cortisol regular, a CM_UVP-FPC notifica-o da cessação do impedimento de competir. Caso se mantenha com resultado analítico ao cortisol irregular após a segunda amostragem, caberá à CM_UVP-FPC em conjunto com o médico da equipa determinar as condições para aptidão e, bem assim, decidir sobre a manutenção do impedimento de competir, o qual apenas poderá ser deliberado se houver unanimidade entre os três membros da Comissão.

- 4.039** Sempre que um corredor apresentar um valor de cortisol abaixo do valor de referência para a definição de normalidade analítica estabelecido pela CM_UVP-FPC em vigor à data da irregularidade, sem ter declarado o procedimento previsto em 4.033, bem como sempre que se verifique qualquer infracção ao presente Regulamento, esta informação será remetida ao Conselho de Disciplina e à Direcção da UVP-FPC, para posterior comunicação, sendo caso disso, à ADOP.

Sanções

- 4.040** Qualquer violação do disposto no Artigo 4.036, 4.038 e 4.039 consubstanciam a prática de ilícitos disciplinares graves, puníveis nos seguintes termos:
- (i) se a prática da infracção for imputável ao médico da equipa, será este sancionado com suspensão de atividade de 1 (um) mês a 3 (três) meses e, acessoriamente, multa de €1.000 (mil euros) a €3.000 (três mil euros); e/ou,
 - (ii) se a prática da infracção for imputável ao corredor, será este sancionado com suspensão de atividade de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês e, acessoriamente, multa de €500 (quinhentos euros) a €1.000 (mil euros).

Capítulo V – DISPOSIÇÕES FINAIS

- 5.001** Tendo as sanções previstas no presente Regulamento natureza disciplinar, a sua aplicação compete ao Conselho de Disciplina da FPC.
- 5.002** Na determinação da responsabilidade disciplinar, é subsidiariamente aplicável o disposto no Regulamento Disciplinar da FPC.
- 5.003** O presente Regulamento, aprovado pela Direcção da FPC na reunião do dia 28.12.2022, entra em vigor no primeiro dia da época desportiva 2023.

